Kryminalizacja posiadania marihuany

Konopie jako przedmiot polityki narkotykowej

Marihuana to potoczne określenie suszu konopi używanego ze względu na działanie psychoaktywne. Nie obejmuje wszystkich produktów konopnych. **Kryminalizacja posiadania** polega na objęciu określonego zachowania zakazem karnym. Używanie, posiadanie, uprawa, udzielanie i handel to odrębne zachowania, nawet gdy występują w tej samej sytuacji.

Konopie są najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem w Europie. EUDA szacuje w raporcie z 2026 r., że **8,7% dorosłych w wieku 15-64 lata**, około 25 mln osób, używało ich w ostatnim roku. To syntetyczne oszacowanie z badań krajowych o różnym czasie realizacji i nieco różnych granicach wieku; nie jest wynikiem jednego badania wszystkich mieszkańców Europy. Źródło: EUDA, 2026, *European Drug Report - Cannabis*.

W polskim badaniu **„Młodzież 2021”** CBOS marihuana i haszysz były najczęściej używanymi nielegalnymi substancjami wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Wyniku tej populacji nie można traktować jako odsetka wszystkich Polaków. Źródło: KCPU, *Rekomendacje 2025*, s. 57, omówienie badania.

Od handlu opium do międzynarodowej kontroli

Historia regulacji narkotyków łączy interesy gospodarcze, politykę kolonialną i ochronę zdrowia. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska uczestniczyła w rozwoju handlu opium produkowanym w Indiach i kierowanym do Chin. Chińskie zakazy nie usunęły interesów handlowych i przemytu. **Wojny opiumowe 1839-1842 i 1856-1860** pokazują konflikt między kontrolą opium a polityką mocarstw; nie były działaniami profilaktycznymi w dzisiejszym znaczeniu.

Opium, morfina i później heroina funkcjonowały także w medycynie. Historyczne stosowanie substancji jako leku nie jest dowodem jej bezpieczeństwa, a późniejszy zakaz nie oznacza, że nie może istnieć żadne zastosowanie lecznicze. Źródło historyczne: UNODC, 2008, *World Drug Report*, rozdział 2, „A Century of International Drug Control”, egzemplarz w Bibliotece Cyfrowej ONZ.

Międzynarodowa konwencja opiumowa, podpisana w Hadze 23 stycznia 1912 r., była pierwszym międzynarodowym traktatem kontroli narkotyków. Poprzedziła ją komisja opiumowa w Szanghaju w 1909 r. Źródła: UNODC, 2009, *Chronology: 100 years of drug control*; ONZ, rejestr konwencji haskiej.

USA: Marihuana Tax Act i raport La Guardii

Marihuana Tax Act z 1937 r. wykorzystywał regulację podatkową i rejestracyjną do kontroli obrotu konopiami. Stanowi element szerszej historii amerykańskiej polityki opisanej w historii kontroli narkotyków w USA.

Raport komisji burmistrza La Guardii z 1944 r., *The Marihuana Problem in the City of New York*, podważał część ówczesnych alarmistycznych tez, m.in. o nieuchronnym przechodzeniu od marihuany do morfiny lub heroiny. Było to opracowanie historyczne, oparte na badaniach środowiskowych w Nowym Jorku i części klinicznej z dobraną grupą uczestników; nie była to reprezentatywna próba współczesnych użytkowników. Nie uzasadnia wniosku, że konopie nigdy nie wywołują uzależnienia. Źródła: Mayor’s Committee on Marihuana, 1944, wnioski części socjologicznej, dobór uczestników części klinicznej; opis bibliograficzny, Wellcome Collection.

Polska - ewolucja odpowiedzialności za posiadanie

Rok	Rozwiązanie
1997	Ustawa objęła posiadanie zakazem karnym, lecz art. 48 ust. 4 wyłączał karalność posiadania nieznacznej ilości na własny użytek. Nie był to ogólny wyjątek legalizujący narkotyki.
2000	Nowelizacja skreśliła art. 48 ust. 4, usuwając tę podstawę niekaralności.
2005	Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii uregulowała odpowiedzialność za posiadanie w art. 62.
2011	Dodano art. 62a, pozwalający umorzyć postępowanie w określonych sprawach posiadania nieznacznej ilości na własny użytek.
2017	Stworzono podstawę wykorzystania określonych produktów konopi jako surowców farmaceutycznych do leków recepturowych.

Źródła: ustawa z 24 kwietnia 1997 r., art. 48; ustawa z 26 października 2000 r., art. 1 pkt 23; ustawa z 1 kwietnia 2011 r., art. 1 pkt 15; ustawa z 7 lipca 2017 r.; ustawa z 29 lipca 2005 r., tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 1939.

Posiadanie a umorzenie postępowania

Art. 62a nie znosi przestępności posiadania. Pozwala umorzyć postępowanie, także przed formalnym wszczęciem, gdy ilość jest nieznaczna i przeznaczona na własny użytek, a orzeczenie kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości. Nie jest to automatyczny nakaz umorzenia każdej sprawy użytkownika.

Źródło prawne: art. 62 i 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst wskazany wyżej. Aktualne omówienie konstrukcji: Paweł Bachmat, Paulina Banaszak-Grzechowiak, Konrad Buczkowski, Julia Kosonoga-Zygmunt i Łukasz Pohl, IWS, 2026, *Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek - obraz prawnoporównawczy oraz praktyka ścigania*, s. 5-8, raport. Jest to analiza prawna; nie dowodzi skuteczności danego modelu w ograniczaniu używania.

Uzasadnienia i funkcje kryminalizacji

Instrumentalne uzasadnienie wskazuje dobro wymagające ochrony, np. zdrowie publiczne, oraz oczekiwany mechanizm ograniczenia szkód. Twierdzenie, że karanie posiadania ułatwi ściganie handlu, jest hipotezą o działaniu polityki: wymaga sprawdzenia, czy postępowania wobec użytkowników rzeczywiście prowadzą do poważniejszych spraw i jakim kosztem.

Kryminalizacja uproszczona oznacza tu przesunięcie reakcji na łatwiejsze do ujawnienia zachowanie poprzedzające lub towarzyszące działalności, którą państwo chce ograniczyć. Samo posiadanie nie dowodzi jednak handlu. Zatarcie tej różnicy może prowadzić do oceniania użytkownika według założeń dotyczących dystrybutora.

Funkcja symboliczna dotyczy publicznego potępienia zachowania i komunikowania granic norm. Może współistnieć z funkcją ochronną, ale samo mocne potępienie nie jest dowodem skuteczności zdrowotnej.

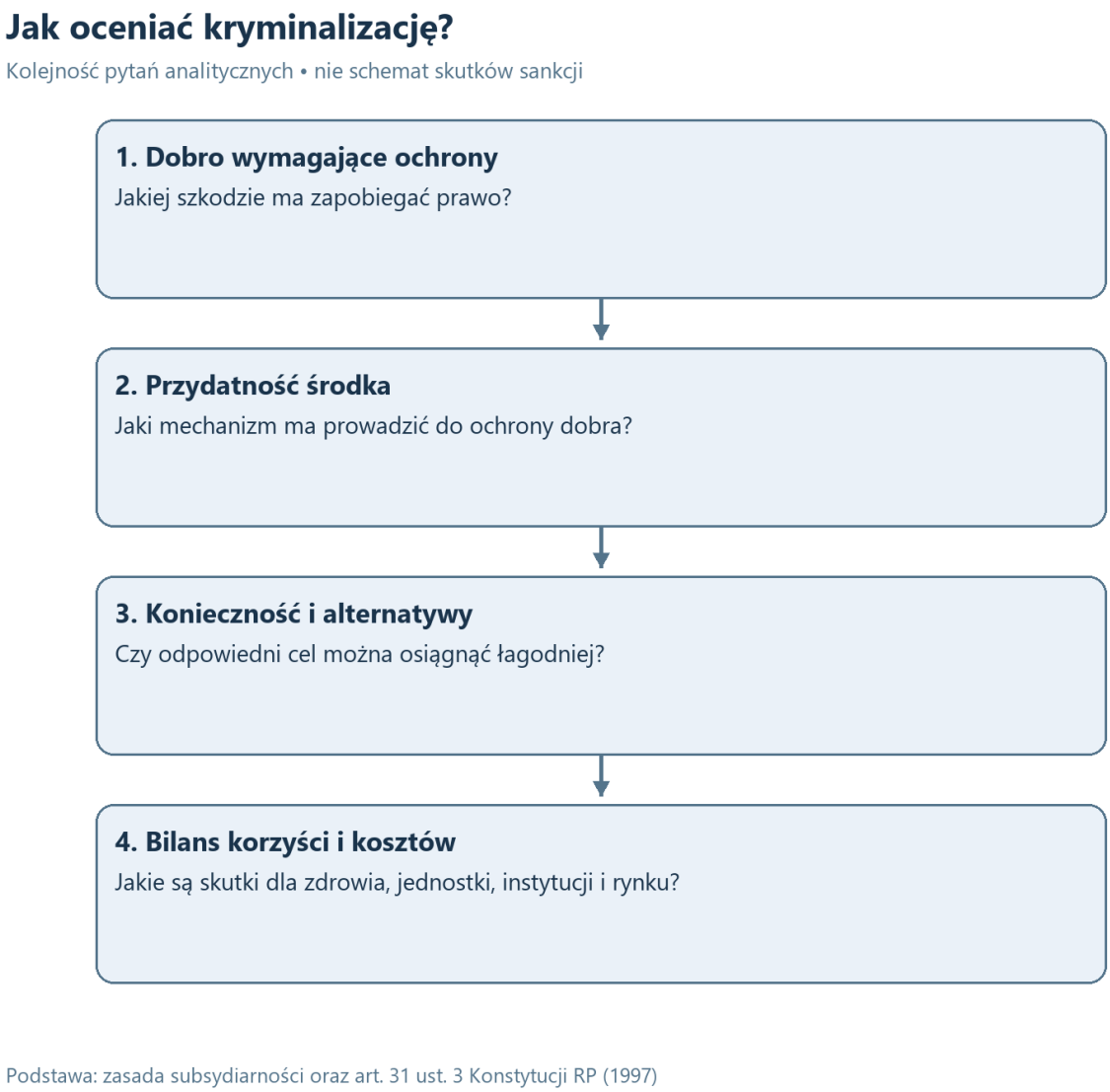
„Dogodny wróg” - Christie i Bruun

W krytycznej koncepcji **Nilsa Christiego i Kettila Bruuna** problem narkotyków może pełnić rolę dogodnego wroga: łączyć społeczne lęki, dostarczać wspólnego przedmiotu potępienia i uzasadniać rozszerzanie kontroli. Wróg powinien być przedstawiany jako niebezpieczny, a zarazem pozostawać wystarczająco trwały, by stale uzasadniać mobilizację. To **interpretacja politycznych funkcji kontroli**, a nie dowód, że szkody narkotykowe są fikcyjne lub że każda regulacja ma ukryty cel.

Literatura: Nils Christie i Kettil Bruun, *Den gode fiende: narkotikapolitikk i Norden*, 1985, opis wydań w katalogu bibliotecznym; Juha Partanen, 2006, rozmowa w „Addiction” o politycznych funkcjach problemu narkotyków.

Subsydiarność prawa karnego

Subsydiarność oznacza traktowanie prawa karnego jako środka ostatecznego - **ultima ratio**. Ingerencja wymaga wskazania dobra, uzasadnienia przydatności sankcji i porównania jej z mniej dolegliwymi możliwościami, np. profilaktyką, leczeniem lub regulacją administracyjną. Nie wynika z tego, że każdy środek pozakarny zawsze wystarcza.



Schemat. Kolejne zagadnienia oceny kryminalizacji: dobro, mechanizm ochrony, alternatywy i bilans szkód. Strzałki pokazują tok analizy, nie dowiedziony wpływ sankcji na używanie. Podstawa: art. 31 ust. 3 Konstytucji i zasada subsydiarności.

Konstytucyjny wymóg konieczności ograniczeń praw wiąże ocenę celu z oceną środka; nie wystarcza nazwać celu pożądanym. Źródło: Konstytucja RP, 1997, art. 31 ust. 3. Powiązanie: Godność i granice karania.

Zdrowie publiczne i interpretacja danych

Konopie mogą powodować uzależnienie oraz wiązać się z problemami oddechowymi i psychicznymi. Ryzyko nie jest jednakowe dla wszystkich: znaczenie mają m.in. częstotliwość używania, wiek rozpoczęcia i moc produktu. Źródło: EUDA, 2025, *Cannabis - the current situation in Europe*.

Liczba osób leczonych nie jest miarą odsetka uzależnionych wśród użytkowników. Zależy również od dostępności terapii, zasad rejestracji i kierowania przez wymiar sprawiedliwości. W raporcie EUDA 2026 konopie odpowiadają za około jedną trzecią zgłoszeń do leczenia narkotykowego w Europie; nie oznacza to, że jedna trzecia osób używających konopi wymaga terapii. Źródło: EUDA, 2026.

Bilans korzyści i kosztów polityki

Ocena kryminalizacji obejmuje co najmniej cztery obszary:

- **Zdrowie i bezpieczeństwo:** używanie problemowe, szkody zdrowotne, dostęp do pomocy, bezpieczeństwo ruchu i otoczenia.
- **Sytuację jednostki:** koszty postępowania i sankcji, stygmatyzację oraz konsekwencje zawodowe i rodzinne.
- **Funkcjonowanie instytucji:** czas i środki policji, prokuratury i sądów; relację między sprawami użytkowników i organizatorów rynku.
- **Nielegalny rynek:** dostępność, ceny, struktury dystrybucji, przemoc i przepływy zysków.

Są to kategorie oceny, a nie stwierdzenie, że każde następstwo występuje zawsze. Rzetelna ewaluacja porównuje podobne populacje i okresy, uwzględnia zmiany wykrywalności oraz oddziela cele polityki od uzyskanych rezultatów. Rozwinięcie: Pomiar i wyjaśnianie przestępczości i Ewaluacja.

Konopie do celów medycznych

Dopuszczenie medyczne nie oznacza ogólnej legalizacji rekreacyjnego posiadania. Ustawa z 7 lipca 2017 r. wprowadziła art. 33a-33d: określone produkty konopi mogą stanowić surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. To regulowany obieg produktu leczniczego. Źródło: ustawa, Dz.U. 2017 poz. 1458.

Prawna dostępność leku i dowód skuteczności w określonym wskazaniu są odrębnymi zagadnieniami. Sam termin „medyczna marihuana” nie określa dawki, składu produktu ani bilansu korzyści i ryzyka dla konkretnej choroby.

Powiązania

- Rynek narkotykowy i historia polityki USA - międzynarodowy i instytucjonalny kontekst regulacji.
- Bentham - kara wymaga uzasadnienia większą korzyścią i porównania z łagodniejszym środkiem.
- Pomiar przestępczości - więcej ujawnionych spraw może wynikać ze sposobu działania służb, a nie tylko ze wzrostu zjawiska.

Źródła internetowe: dostęp 27.10.2026. Oś zmian prawa obejmuje wskazane akty historyczne; konstrukcję art. 62a porównano z analizą IWS z 2026 r.